

Alle um einen autistischen Studierenden / eine autistische Studierende

Der kumulative Leitfaden für das ganze Team um eine autistische Studierenden / einen autistischen Studierenden (~18–25 Jahre) — Familie, Dozierende & Hochschulpersonal, Übungsleiter:innen/Gruppen-Leitende, Ärzt:innen & Studierenden-Gesundheits-Pflegekräfte, Behinderten-Begleitkräfte, Arbeitgebende (Praktika/Jobs) und Peers. Ein erweitertes Nachschlagewerk; kombinieren Sie es mit den Einzel-Gegenstücks-Kurzanleitungen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit einer Studierenden/eines Studierenden in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Das Studium ist ein *gewaltiger* Übergang — neue Autonomie, weniger Struktur, überall Großraum, Gruppenarbeit und sozialer Druck — und viele autistische Studierende, die in der Schule aufblühten, **prallen im ersten oder zweiten Jahr an eine Wand** (Burnout, Angst oder Krise). Ihre fokussierten Interessen sind eine echte akademische Stärke; das System um sie herum ist meist das Problem. Welche Rolle Sie auch haben, die Hebel sind dieselben: schützen Sie Fokus, fügen Sie Vorhersagbarkeit hinzu, kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich, und behandeln Sie Burnout als das Reale, Eigenständige, das es ist. Ein koordiniertes, akzeptierendes Team ist oft der Unterschied zwischen einer Studierenden, die aufblüht, und einer, die leise geht.

Was in jedem Setting hilft

- **Schützen Sie Fokus und das Spezialinteresse** — strukturieren Sie Studium, Arbeit und Unterstützung um weniger, tiefere „Tunnel statt Aufgaben“; begrenzen Sie niemals eine gesunde Leidenschaft.
- **Fügen Sie Vorhersagbarkeit hinzu** — klare Pläne, Vorankündigung von Wechseln, konsistente Personen; legen Sie das Wesentliche schriftlich fest.
- **Kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich**, eins nach dem anderen; gewähren Sie Verarbeitungszeit; bieten Sie asynchrone Optionen.
- **Senken Sie sensorische und soziale Last** — ruhigere Räume, weniger erzwungene Gruppen-/Sozial-Forderungen, flexible Teilnahme.
- **Behandeln Sie Burnout als real** — Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Toleranz brauchen *reduzierte Last und Entmasken*, nicht „Durchziehen“; eine vorübergehende Lastreduktion oder ein Studienunterbruch ist ein legitimer Erholungsschritt.
- **Kennen Sie die Wegweiser und gehen Sie *mit ihnen*** — Behindertenservice, Wohlbefinden, Mentoring, autistische Studierenden-Communities, Krisenhotlines.

Was Sie in jedem Setting vermeiden sollten

- Standardmäßig „typischer Studierendenstress“ und damit Burnout oder eine Ersterkennung übersehen.
- Überraschungswechsel, obligatorische Gruppenarbeit/„Cold-calling“ ohne Alternative oder „Durchzieh“-Rat, der Masking erhöht.

- Schweigen, einen flachen Affekt oder Selbstvernachlässigung mit „entscheidet sich, nicht mitzumachen“ gleichsetzen.
- Für sie entscheiden — unterstützen Sie Autonomie und Wahl.

Kurzhinweise für jede Person um die Studierende / den Studierenden

Familie

Glauben Sie ihr. Helfen Sie beim Praktischen, wenn darum gebeten (Behindertenservice, Anpassungen, Termine, Finanzen). Normalisieren Sie reduzierte Last und schützen Sie ihre Ruhepausen; kommunizieren Sie schriftlich, auf ihre Bedingungen. Nehmen Sie privates Zusammenbrechen und Rückzug ernst.

Dozierende & Hochschulpersonal

Legen Sie Folien, Anweisungen, Fristen und Kriterien schriftlich und im Voraus fest; bieten Sie flexible Teilnahme und alternative Prüfung; verweisen Sie früh an den Behindertenservice. Eine reduzierte Last in einer Krise ist ein Erholungsschritt, kein Scheitern.

Übungsleiter:innen & Gruppen-Leitende

Machen Sie das Training vorhersagbar und teilen Sie den Plan vorab; bieten Sie sensorisch arme, druckarme Sozial-Optionen und machen Sie Initiationen niemals obligatorisch. Halten Sie die Mitgliedschaft flexibel; eine reduzierte Rolle mitten im Semester hält eine kämpfende Studierende verbunden.

Ärzt:innen & Studierenden-Gesundheits-Pflegekräfte

Erkennen Sie **autistisches Burnout** und screenen Sie direkt auf Suizidalität. Bieten Sie schriftliche/Online-Termine und eine Begleitperson; behandeln Sie Selbstvernachlässigung und Rückzug als unerfüllten Bedarf. Verweisen Sie an Wohlbefinden, Mentoring und Krisen-Unterstützung.

Behinderten-Begleitkräfte & Mentor:innen

Seien Sie die vorhersagbare Beziehung; kommunizieren Sie schriftlich; schützen Sie Fokus und zerlegen Sie Aufgaben in Schritte. Normalisieren Sie Fristverlängerungen/Verschiebungen; kennen Sie die Wegweiser und gehen Sie mit. Fragen Sie wörtlich nach, wenn sie still wird.

Arbeitgebende (Praktika / Nebenjobs)

Seien Sie explizit über Erwartungen und ungeschriebene Regeln; bieten Sie schriftliche Anweisungen und geschützten Fokus; geben Sie wörtliches, freundliches Feedback. Ein Praktikum neben dem Studium ist viel — Flexibilität verhindert Burnout.

Peers & Mitbewohner:innen

Vereinbaren Sie WG-Normen früh und schriftlich; standardmäßig texten; schützen Sie Ruhezeiten. Verbinden Sie sich über das Interesse und fragen Sie wörtlich nach. Wenn sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, behalten Sie es nicht für sich.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Toleranz) und **Suizidalität** — screenen Sie und fragen Sie direkt. Begleitende **ADHD, Angst, Schlaf- und GI-Zustände** verdienen autismus-informierte Versorgung. Eine vorübergehende Reduktion der Studienlast oder ein Studienunterbruch ist ein evidenzangemessener Erholungsschritt, kein Scheitern.

Wenn die Studierende / der Studierende eine Frau ist

Frauen und Studierende marginalisierter Geschlechter sind unter den spät-erkannten überrepräsentiert und masken stark. Ein „leistungsstarkes, oberflächlich geselliges“ Erscheinungsbild mit privatem Zusammenbruch ist ein Schlüsselmuster — nehmen Sie die Lücke zwischen öffentlicher Leistung und privater Erschöpfung über jedes Setting ernst.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4), **Monotrop aufwachsen** (Teil 3) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Studierende / den einzelnen Studierenden an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019/2023); Dwyer (2025); Wood (2019, Interessen & Inklusion); Knight (2021, *Tunnel statt Aufgaben*); Raymaker et al. (2020, Burnout); Pearson & Rose (2021, Masking); Michaud & Harvey (2025). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.